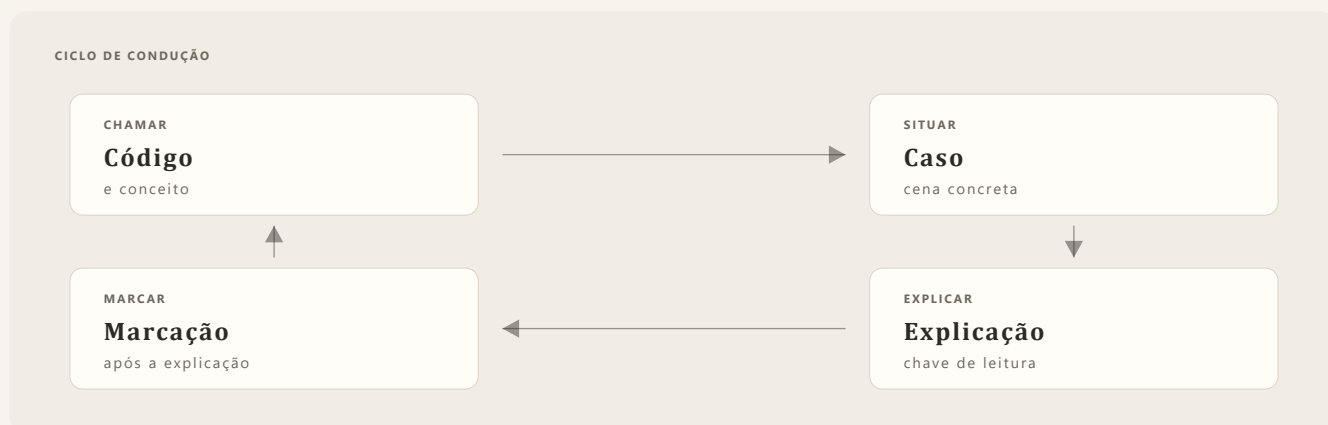


Carta de explicações rápidas

Apoio objetivo para conduzir o baralho de chamadas com clareza, ritmo e unidade conceitual.



Como usar

- Sorteie a carta, anuncie o código e o conceito.
- Leia o caso do baralho de chamadas.
- Use a explicação do código como apoio para uma fala de 20 a 40 segundos.
- Depois dê alguns segundos para marcação e siga a rodada.
- Na conferência, volte à explicação e à pergunta da carta para validar a linha.

Mapa rápido

Código	Bloco	Função didática
B01-B15	Base moral	fundamento cristão do tema
I01-I15	Situações concretas	situações concretas do tema
N01-N15	Narrativas falsas	desculpas que normalizam o erro
G01-G15	Discernimentos	distinções para discernir
O01-O15	Orientações de resposta	respostas proporcionais e prudentes

B - BASE MORAL

B01	Não matarás O mandamento Não matarás protege a vida inocente também quando ela está frágil. A dor não autoriza transformar a morte em solução. A resposta cristã é cuidar, aliviar e acompanhar. Ex 20,13 · CEC 2277
B02	Imagem de Deus A pessoa vale porque é imagem de Deus, não porque conserva memória, força ou autonomia. A doença pode tirar capacidades, mas não tira dignidade. Por isso o cuidado não depende do desempenho do paciente. Gn 1,27 · CEC 1700
B03	Vida como dom A vida é dom, não propriedade absoluta. Isso não diminui a dor de quem sofre, mas corrige a ideia de poder total sobre a própria morte. A liberdade cristã responde a Deus e ao bem. Rm 14,7-8 · 1Cor 6,19-20
B04	Criador e Senhor Deus é o Criador e Senhor da vida. Nenhum hospital, família ou Estado recebe autoridade para decidir que uma vida inocente deve ser eliminada. A gestão de crises não pode virar poder de matar. CEC 2277 · Rm 14,7-8
B05	Dignidade do enfermo A dignidade do enfermo exige respeito especial. Falar sobre ele como problema, custo ou peso já fere essa dignidade. A fé manda reconhecer a pessoa presente e cuidar dela. CEC 2276 · Mt 25,36
B06	Pessoa até o fim A pessoa continua pessoa até o fim. Coma, terminalidade ou deficiência grave não transformam alguém em coisa. O discernimento clínico deve existir sem apagar a dignidade pessoal. CEC 2276 · B02
B07	Respeito especial A vulnerabilidade exige respeito especial. Quem tem menos voz precisa de mais proteção, não de menos cuidado. A omissão diante do frágil abre caminho para abusos e falsas soluções. CEC 2276 · Mt 25,36
B08	Eutanásia direta A eutanásia direta provoca a morte para suprimir sofrimento. O Catecismo a considera moralmente inadmissível. A compaixão verdadeira nunca transforma matar em cuidado. CEC 2277 · Ex 20,13
B09	Intenção de matar Na eutanásia, a intenção de matar é decisiva. Uma medicação pode aliviar dor, mas também pode ser usada para causar morte. O critério moral pergunta o que se quer, por que se quer e por que meio se age. CEC 2277 · G02

B10 Caridade que cuida

A **caridade que cuida** permanece quando a cura já não vem. Ela limpa, visita, alivia e escuta. Não é misericórdia matar; é misericórdia cuidar.

Mt 25,36 · CEC 2279

B11 Visita ao doente

A **visita ao doente** é encontro concreto com Cristo. Muitas vezes ninguém consegue resolver a doença, mas pode romper o abandono. Presença fiel é cuidado real.

Mt 25,36 · CEC 1503

B12 Cuidados devidos

Os **cuidados devidos** permanecem mesmo quando a morte é iminente. Higiene, conforto, presença e alívio proporcionado não podem ser abandonados. Alimentação e hidratação pedem avaliação de proporção, nunca intenção de matar.

CEC 2279 · G14

B13 Esperança cristã

A **esperança cristã** não nega a gravidade da morte. Ela impede que o sofrimento seja lido como perda de valor ou abandono de Deus. A pessoa pode ser sustentada pela graça e pelo cuidado.

2Cor 12,9 · CEC 1520

B14 Consciência formada

A **consciência formada** não decide por impulso, medo ou pressão. Diante da morte, é preciso buscar verdade, doutrina, informação médica séria e prudência. Consciência não é palpite; é juízo moral responsável.

CEC 1776 · CEC 1783

B15 Sofrimento acompanhado

O **sofrimento acompanhado** não é romantizado nem usado para justificar morte. A dor precisa ser aliviada com seriedade. A fé acompanha a pessoa no limite, sem abandonar nem eliminar.

CEC 2279 · 2Cor 12,9

I - SITUAÇÕES CONCRETAS**I01 Pedido de morte**

O **pedido de morte** pode esconder dor, medo, solidão ou depressão. Ele deve ser levado a sério, mas não executado. A resposta correta é investigar o sofrimento e oferecer cuidado.

CEC 2277 · G11

I02 Dor sem controle

A **dor sem controle** é uma falha grave de cuidado. Quando a dor é abandonada, a morte começa a parecer solução. O caminho cristão exige analgesia proporcional e cuidados paliativos.

CEC 2279 · O01

I03 Tratamento fútil

O **tratamento fútil** pode prolongar sofrimento sem servir ao paciente. Recusar esse tipo de procedimento pode ser legítimo. Isso é diferente de desejar ou provocar a morte.

CEC 2278 · G05

I04	UTI sem benefício A UTI sem benefício pode virar obstinação terapêutica. Nem todo suporte técnico é cuidado verdadeiro. A decisão prudente aceita limites da medicina e mantém cuidados devidos. CEC 2278 · G07
I05	Sedação no fim A sedação no fim pode ser moralmente lícita quando busca aliviar sofrimento intolerável. O ponto decisivo é não desejar a morte como fim nem como meio. A intenção e a proporção devem ficar claras. CEC 2279 · G06
I06	Alimentação suspensa A alimentação suspensa exige discernimento sério. Retirar cuidado proporcionado porque a pessoa não fala ou incomoda pode ser abandono. É preciso avaliar benefício, possibilidade e intenção. CEC 2279 · G14
I07	Idoso pressionado O idoso pressionado pode aceitar a morte para não pesar sobre os outros. Essa pressão nem sempre aparece como ameaça direta. Proteger sua liberdade exige afirmar valor e oferecer apoio concreto. CEC 2276 · N03
I08	Coma prolongado No coma prolongado, a comunicação visível desaparece. A dignidade da pessoa, porém, permanece. O cuidado deve ser proporcional sem tratar o paciente como coisa. B06 · CEC 2276
I09	Deficiência grave A deficiência grave nunca torna a vida menos humana. A sociedade pode ter dificuldade de cuidar, mas não pode medir dignidade por autonomia. A resposta cristã é amparo e respeito especial. B02 · CEC 2276
I10	Família exausta A família exausta precisa de ajuda real. O cansaço explica a crise, mas não pode decidir o valor da vida do doente. Apoiar cuidadores protege todos. G15 · O09
I11	Médico pressionado O médico pressionado deve guardar a consciência e a finalidade da medicina. A competência profissional serve para cuidar, não para eliminar. Recusar eutanásia não é abandonar o paciente. B14 · O15
I12	Herança apressada A herança apressada contamina o discernimento. Dinheiro, patrimônio e pressa não podem entrar no lugar do bem do paciente. O vulnerável precisa ser protegido contra interesses ocultos. N06 · B07

I13	Seguro nega cuidado Quando o seguro nega cuidado, a pressão econômica cresce. A falta de alívio e orientação pode empurrar para escolhas erradas. Defender cuidado proporcional também é defender a vida. N06 · O14
I14	Solidão hospitalar A solidão hospitalar aumenta o sofrimento. Procedimento correto não substitui presença humana. Visitar, ligar e permanecer podem impedir que a pessoa se sinta descartada. Mt 25,36 · O12
I15	Documento ambíguo O documento ambíguo mistura coisas moralmente diferentes. Recusar tratamento fútil pode ser lícito; pedir morte provocada não. A vontade razoável deve ser registrada com clareza. CEC 2278 · B08

N · NARRATIVAS FALSAS

N01	Falsa compaixão A falsa compaixão quer acabar com a dor eliminando quem sofre. Ela parece sensível, mas erra o objeto da ação. A compaixão cristã trata a dor e permanece com a pessoa. CEC 2277 · CEC 2279
N02	Falsa dignidade A falsa dignidade usa palavras nobres para defender morte provocada. Dignidade não significa poder ser morto quando a vida pesa. Morrer com dignidade é ser cuidado e respeitado até o fim. B05 · CEC 2276
N03	Mentira de ser peso A mentira de ser peso nasce quando a pessoa mede sua vida pelo trabalho que dá. Dependência não retira valor. A resposta é afirmar dignidade e organizar ajuda concreta. B02 · I07
N04	Vida sem utilidade A lógica da vida sem utilidade mede pessoas por produção, autonomia ou economia. Isso contradiz a fé cristã. O ser humano vale por ser pessoa criada por Deus. B06 · CEC 1700
N05	Autonomia absoluta A autonomia absoluta transforma liberdade em poder ilimitado. Mas a vida é dom e responsabilidade diante de Deus. Nenhuma escolha pessoal autoriza exigir que outro mate. B03 · Rm 14,7-8
N06	Custo decide a vida Quando o custo decide a vida, os vulneráveis se tornam descartáveis. Limites econômicos existem, mas não podem definir quem deve morrer. A justiça administra recursos sem eliminar pessoas. B07 · I13

N07	Dor sem sentido A narrativa da dor sem sentido conclui que sofrer é perder valor. Isso é falso. A dor deve ser aliviada e acompanhada, não usada como sentença contra a vida. B15 · CEC 2279
------------	---

N08	Morte como cuidado Chamar a morte como cuidado confunde palavras e consciências. Cuidar é aliviar e acompanhar; eutanásia é provocar a morte. A verdade da linguagem protege o doente. B08 · G06
------------	---

N09	Progresso que elimina O progresso que elimina chama de avanço aquilo que enfraquece os frágeis. Uma sociedade não se torna mais humana quando facilita matar vulneráveis. O progresso real cuida melhor. B07 · CEC 2277
------------	--

N10	Legal então moral A ideia legal então moral confunde lei civil com lei moral. Uma prática permitida pode continuar gravemente errada. A consciência cristã deve ser formada pela verdade. Ex 20,13 · B14
------------	---

N11	Só antecipar o fim Dizer só antecipar o fim minimiza um ato grave. A proximidade da morte não autoriza provocá-la. Até o último momento permanece o dever de não matar e de cuidar. CEC 2277 · G14
------------	---

N12	Amor que elimina O amor que elimina é amor ferido e desordenado. Ele quer tirar a dor, mas acaba tirando a vida da pessoa amada. A caridade verdadeira permanece e protege. B10 · Mt 25,36
------------	---

N13	Invisibilidade cômoda A invisibilidade cômoda abandona o doente e depois chama a morte de solução. Quando ninguém visita, a vida parece mais descartável. A resposta cristã rompe o isolamento. B11 · I14
------------	--

N14	Cansaço como critério O cansaço como critério nasce de um sofrimento real dos cuidadores. Mesmo assim, cansaço não mede o valor do doente. Ele pede apoio, revezamento e orientação. I10 · G15
------------	---

N15	Escolha sem ferida A escolha sem ferida apresenta a eutanásia como ato privado e limpo. Mas ela envolve paciente, família, profissionais e cultura. Normalizar matar fere todo o tecido moral. B08 · I11
------------	---

G · DISCERNIMENTOS

G01	Matar ou permitir morrer Matar ou permitir morrer são realidades diferentes. Recusar obstinação aceita que a morte não pode ser impedida. Eutanásia provoca a morte e por isso é inadmissível. CEC 2277 · CEC 2278
------------	---

G02	Intenção ou efeito Intenção ou efeito é distinção decisiva. Aliviar dor pode ter riscos previstos, mas não desejados. Querer a morte como fim ou meio muda a natureza moral do ato. CEC 2279 · B09
------------	---

G03	Dor ou desespero Dor ou desespero pedem respostas diferentes. Dor física exige tratamento; desespero exige escuta, presença e proteção. O pedido de morte não deve ser lido de modo simplista. I02 · O05
------------	---

G04	Ordinário ou extraordinário Ordinário ou extraordinário evita confusões graves. Cuidados comumente devidos permanecem. Tratamentos extraordinários e desproporcionais podem ser recusados sem intenção de matar. CEC 2278 · CEC 2279
------------	---

G05	Proporcionado ou fútil Proporcionado ou fútil pergunta se o recurso serve ao bem real do paciente. Nem todo procedimento possível é obrigatório. A técnica deve estar a serviço da pessoa. CEC 2278 · I03
------------	--

G06	Sedação ou eutanásia Sedação ou eutanásia podem parecer próximas por fora. A diferença está na intenção, no meio e na proporção. Sedar para aliviar pode ser lícito; sedar para matar não. CEC 2279 · I05
------------	--

G07	Cuidado ou obstinação Cuidado ou obstinação distingue permanecer fiel de insistir em técnica inútil. Recusar obstinação não significa abandonar. Significa cuidar de modo proporcionado quando curar não é possível. CEC 2278 · I04
------------	--

G08	Pessoa ou condição Pessoa ou condição é distinção fundamental. Terminal, inconsciente ou dependente descreve uma situação clínica. Nenhuma dessas palavras substitui o nome e a dignidade da pessoa. B06 · CEC 2276
------------	--

G09	Autonomia ou abandono Autonomia ou abandono mostra que escolha sem apoio pode ser pressão disfarçada. Respeitar o paciente inclui oferecer cuidado real. Sem alternativas, a liberdade fica ferida. CEC 2278 · I07
------------	---

G10	Culpa ou responsabilidade Culpa ou responsabilidade une verdade e misericórdia. O ato de eutanásia continua grave em si. A responsabilidade pessoal pode ser diminuída por medo, ignorância ou pressão. CEC 1735 · CEC 2277
------------	--

G11	Desejo ou pedido Desejo ou pedido não são sempre decisão estável. A frase quero morrer pode surgir no auge da dor ou solidão. Escutar bem significa cuidar antes de concluir. I01 · O05
------------	--

G12	Consciência ou pressão Consciência ou pressão pergunta de onde nasce a decisão. Medo, custos e pressa podem deformar a liberdade. A consciência precisa de verdade, tempo e orientação. B14 · CEC 1783
------------	---

G13	Misericórdia ou banalização Misericórdia ou banalização distingue cuidado profundo de linguagem fácil. A misericórdia se aproxima do sofredor. A banalização transforma a morte provocada em rotina aceitável. B10 · N01
------------	---

G14	Aceitar ou provocar Aceitar ou provocar é uma distinção central. Aceitar a morte inevitável pode ser prudente. Provocar a morte de alguém inocente é eutanásia e deve ser excluído. CEC 2277 · CEC 2278
------------	--

G15	Prudência ou omissão Prudência ou omissão ajuda a não confundir limites da medicina com abandono. Pode ser prudente não insistir em tratamento inútil. Mas cuidados devidos e presença devem continuar. CEC 1806 · CEC 2279
------------	--

O · ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA

O01	Controlar a dor Controlar a dor é resposta concreta e urgente. Dor mal tratada pode alimentar pedidos de morte. Buscar analgesia proporcional é forma séria de cuidado cristão. CEC 2279 · I02
------------	---

O02	Buscar paliativos Buscar paliativos não é desistir do paciente. É mudar o foco para aliviar sofrimento e acompanhar integralmente. O Catecismo chama esse cuidado de caridade desinteressada. CEC 2279 · B10
------------	---

O03	Recusar obstinação Recusar obstinação pode ser moralmente correto. Não se quer matar; aceita-se que certo tratamento já não serve ao paciente. O cuidado devido deve continuar. CEC 2278 · G07
------------	---

O04	Manter cuidados devidos Manter cuidados devidos impede que o fim da cura vire abandono. Higiene, conforto, alívio e presença expressam dignidade. Cuidar continua mesmo quando curar não é possível. CEC 2279 · B12
------------	--

O05	Escutar sem matar Escutar sem matar leva o pedido de morte a sério. A resposta não é executar a morte, mas descobrir dor, medo e solidão. Escuta verdadeira abre caminho de cuidado. I01 · G11
------------	---

O06	Decidir em conjunto Decidir em conjunto reduz pressa, pressão e erro. O paciente capaz deve ser ouvido, e os responsáveis legítimos devem buscar seu bem. A decisão precisa ser informada e prudente. CEC 2278 · B14
------------	---

O07	Pedir segunda opinião Pedir segunda opinião é prudente quando há dúvida grave. Isso ajuda a avaliar diagnóstico, proporção e alternativas. Não é fuga, desde que conduza a uma decisão responsável. CEC 1806 · G05
------------	---

O08	Proteger o vulnerável Proteger o vulnerável é dever cristão e humano. Idosos, doentes e inconscientes podem sofrer pressão sem conseguir se defender. A proteção exige escuta segura e medidas competentes. CEC 2276 · B07
------------	---

O09	Acompanhar a família Acompanhar a família também protege o doente. Cuidadores exaustos precisam de descanso, revezamento e orientação. Sem apoio, o cansaço pode deformar decisões graves. I10 · N14
------------	---

O10	Chamar assistência espiritual Chamar assistência espiritual é cuidado real. Oração, sacramentos e escuta ajudam a pessoa a viver o fim diante de Deus. Isso não substitui tratamento nem justifica abandono. Tg 5,14-15 · CEC 1520
------------	---

O11	Falar com verdade Falar com verdade protege a consciência. Termos vagos podem esconder eutanásia ou confundir recusa de obstinação com abandono. Decisões sérias exigem palavras claras. B08 · G01
------------	---

O12	Organizar presença Organizar presença transforma intenção em cuidado concreto. Visitas curtas, ligações e ajuda prática combatem a solidão. A caridade precisa de tempo e compromisso possível. Mt 25,36 · I14
------------	---

O13	Registrar vontade razoável Registrar vontade razoável pode evitar confusão no fim da vida. O registro deve recusar tratamentos fúteis e pedir cuidados devidos. Não pode incluir pedido de morte provocada. CEC 2278 · I15
------------	---

O14**Denunciar abandono**

Denunciar abandono é proteger a vida vulnerável. Negligência, maus-tratos e recusa injusta de cuidado não devem ser escondidos. A ação deve ser factual, prudente e dirigida a responsáveis competentes.

B07 · I13

O15**Sustentar profissionais**

Sustentar profissionais fiéis à consciência protege a medicina. Recusar cooperar com eutanásia não é abandonar o paciente. É manter o cuidado sem transformar a profissão em instrumento de morte.

B14 · I11